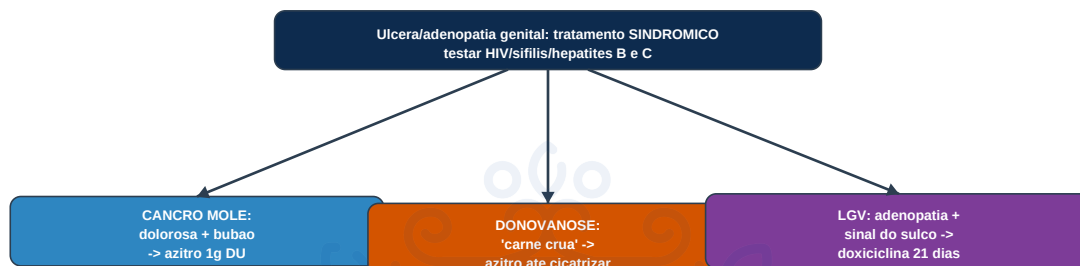


ÚLCERAS GENITAIS — SINDRÔMICO + ISTs

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM SINDRÔMICA

ÚLCERA GENITAL — TRATAR SINDRÔMICO + RASTREAR ISTs



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS ÚLCERAS GENITAIS

Doença	Lesão	Adenopatia
Cancro mole (H. ducreyi)	Úlceras MÚLTIPLAS, DOLOROSAS, fundo sujo/purulento, sangram fácil	Bubão único, doloroso, supurativo (fistuliza)
Donovanose (K. granulomatis)	Úlcera granulomatosa, vermelho-vivo ('carne crua'), INDOLOR, sangra fácil	Ausente (pseudobubão raro)
LGV (C. trachomatis L1-3)	Pápula/úlcera FUGAZ (some)	Inguinal/femoral DOLOROSA, coalescente, SINAL DO SULCO, fístulas
Sífilis (T. pallidum)	Cancro duro: ÚNICO, INDOLOR, base limpa, bordas endurecidas	Unilateral, indolor, não supurativa

REGRAS DE SEGURANÇA

NÃO ERRAR

- Tratamento SINDRÔMICO: iniciar na suspeita clínica, sem aguardar cultura/PCR; sempre cobrir as causas mais prováveis
- Toda úlcera genital ou adenite com duração > 4 semanas torna a BIÓPSIA mandatória (excluir CARCINOMA espinocelular e diferenciar donovanose/LGV)
- LGV é frequentemente confundido no PS com HÉRNIA inguinal encarcerada ou linfadenite — não operar sem investigar
- Bubão flutuante: ASPIRAR com agulha (não incisar amplamente — risco de fístula crônica)
- SEMPRE testar HIV, sífilis, hepatites B e C; vacinar hepatite B se não vacinado; notificar/tratar parceiros

TRATAMENTO — CANCRO MOLE

Rx ÚLCERA DOLOROSA + BUBÃO

1ª linha (escolher um): Azitromicina 1 g VO dose única; ou Ceftriaxona 500 mg IM dose única
Alternativas: Ciprofloxacino 500 mg 12/12h por 3 dias (contraindicado em gestante/lactante); Eritromicina 500 mg 6/6h por 7 dias (segura na gestação)
BUBÃO flutuante e doloroso: aspiração por agulha sob assepsia (repetir se necessário); evitar incisão ampla
Bubão complicado: drenagem cirúrgica só se falha da aspiração/abscesso extenso
PVHIV: mesmo esquema, resposta mais lenta; cuidados locais (higiene, não manipular); tratar parceiros dos últimos 10 dias; abstinência até cicatrizar

TRATAMENTO — DONOVANOSE E LGV

Rx DURAÇÃO É O FATOR CRÍTICO

DONOVANOSE (1ª linha): Azitromicina 1 g VO 1x/semana, MÍNIMO 3 semanas e até a CICATRIZAÇÃO COMPLETA (segura na gestação, preferencial no HIV)
Alternativas: Doxiciclina 100 mg 12/12h (contraindicada na gestação); Eritromicina 500 mg 6/6h; Ciprofloxacino — todas até cicatrizar; grave/falha: associar Gentamicina 1 mg/kg EV 8/8h por ≥ 7 dias
Não cauterizar nem desbridar agressivamente; tratar parceiros dos últimos 60 dias
LGV (1ª linha): DOXICICLINA 100 mg VO 12/12h por 21 DIAS (tratamento < 21 dias = falha)
Alternativa: Azitromicina 1 g VO 1x/semana por 3 semanas; tratar parceiros dos últimos 60 dias
LGV: alertar sobre risco de elefantíase genital/estenose retal se o tratamento for interrompido antes do 21º dia

INTERNAÇÃO, ALTA E SEGUIMENTO

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: sepse/instabilidade; bubão volumoso com sinais sistêmicos; proctite hemorrágica grave (LGV); sangramento intenso/infecção secundária (donovanose); necessidade de drenagem cirúrgica ou ATB EV; falha ambulatorial
- ☐ ALTA: estável, ATB iniciado, dor controlada, orientações compreendidas, seguimento garantido (donovanose/LGV: retorno semanal até cicatrizar)
- ☐ Abstinência sexual até a cicatrização/cura; preservativo após a liberação
- ☐ Convocar e tratar parceiros; rastrear/tratar outras ISTs; encaminhar ao SAE/IST
- ☐ Alta suspeita de malignidade (úlceras/adenite > 4 semanas) -> biópsia mandatória

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com úlcera genital ____ (cancro mole / donovanose / LGV); início há ____; dor ____, bubão/adenopatia ____ (sinal do sulco?).
- Complicação: sepse ____, proctite hemorrágica ____, sangramento ____; HIV/sífilis/hepatites: ____.
- Conduta: ATB sindrômico ____ iniciado às ____; aspiração de bubão ____; parceiros notificados.
- Solicito infectologia/cirurgia (drenagem) / internação se complicação; biópsia se > 4 semanas.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual úlcera genital é tipicamente DOLOROSA, múltipla, de fundo sujo, com bubão inguinal supurativo?

- A) Cancro duro (sífilis)
- B) Cancro mole (*Haemophilus ducreyi*)
- C) Donovanose
- D) Herpes
- E) Carcinoma

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a duração mínima do tratamento do linfogranuloma venéreo (LGV) com doxiciclina?

- A) 7 dias
- B) 21 dias
- C) 3 dias
- D) Dose única
- E) 5 dias

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual lesão caracteriza a donovanose (granuloma inguinal)?

- A) Úlcera dolorosa purulenta
- B) Úlcera granulomatosa vermelho-vivo ('carne crua'), indolor, que sangra fácil
- C) Vesículas agrupadas
- D) Cancro duro indolor de base limpa
- E) Pápula fugaz com bubão

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

No PS, o LGV pode ser confundido com qual condição, levando a conduta cirúrgica desnecessária?

- A) Apendicite
- B) Hérnia inguinal encarcerada / linfadenite inespecífica
- C) Cisto sebáceo
- D) Torção testicular
- E) Varicocele

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Quando a biópsia de uma úlcera genital torna-se mandatória?

- A) Sempre, em toda úlcera
- B) Quando a úlcera ou a adenite persiste por mais de 4 semanas (excluir carcinoma)
- C) Apenas se houver dor
- D) Nunca
- E) Somente em gestantes

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O cancro mole (*H. ducreyi*) cursa com úlceras múltiplas, DOLOROSAS, de fundo sujo/purulento e bubão inguinal doloroso e supurativo; a sífilis (cancro duro) é única e indolor.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O LGV exige 21 dias de doxiciclina (100 mg 12/12h); tratamento mais curto leva a falha e a complicações como elefantíase genital e estenose retal.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A donovanose tem úlcera granulomatosa vermelho-vivo ('carne crua'), indolor, friável e que sangra fácil, geralmente sem adenopatia verdadeira (pseudobubão raro).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O LGV é frequentemente confundido com hérnia inguinal encarcerada ou linfadenite inespecífica; a investigação evita cirurgias desnecessárias e a falha terapêutica.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Toda úlcera genital ou adenite com mais de 4 semanas de duração torna a biópsia mandatória, para excluir carcinoma espinocelular e diferenciar donovanose/LGV.

SM24
Suporte ao Plantão Médico